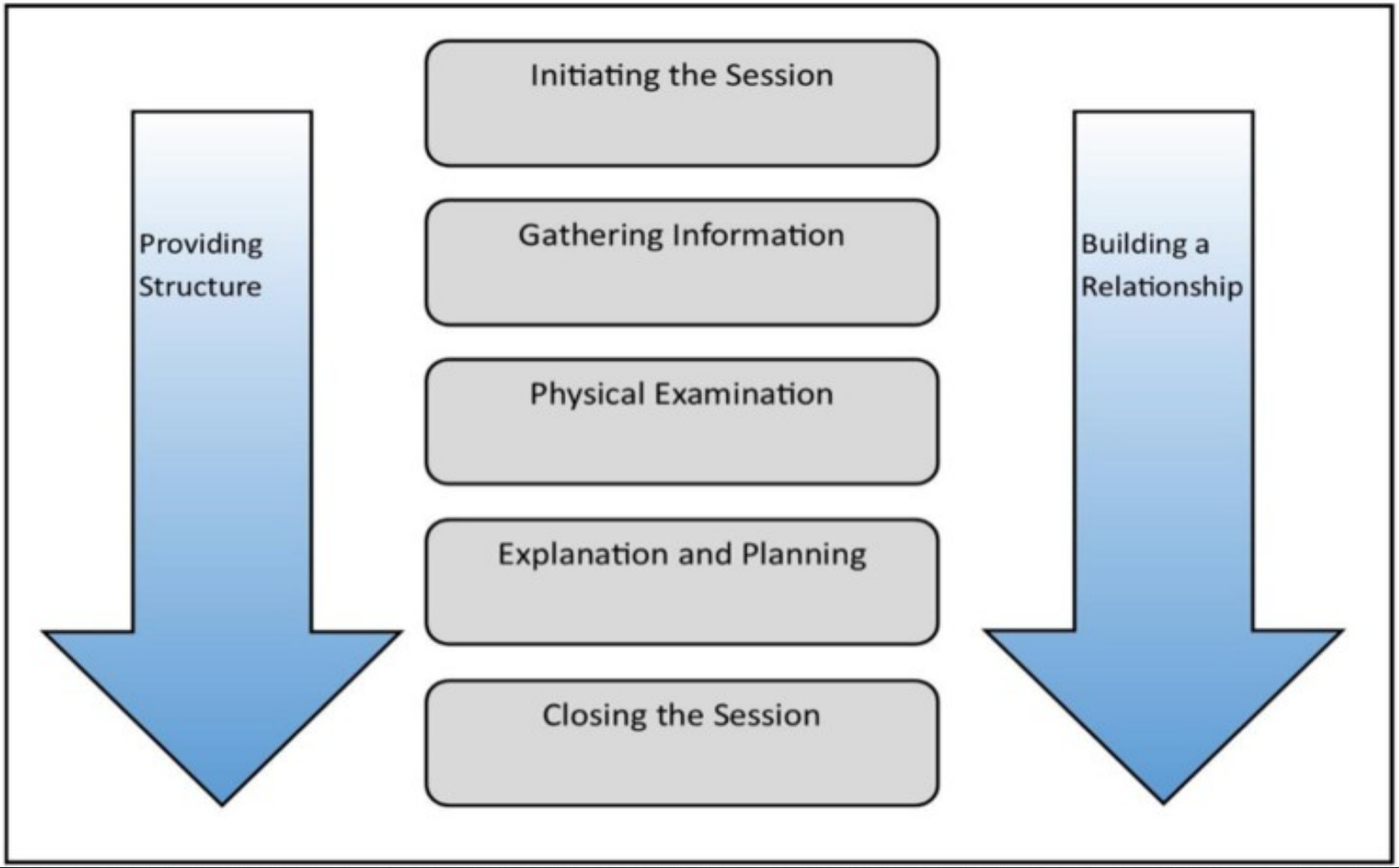


COMMUNICATION SKILLS

DR. BOTAN ABDULKADIR ALI

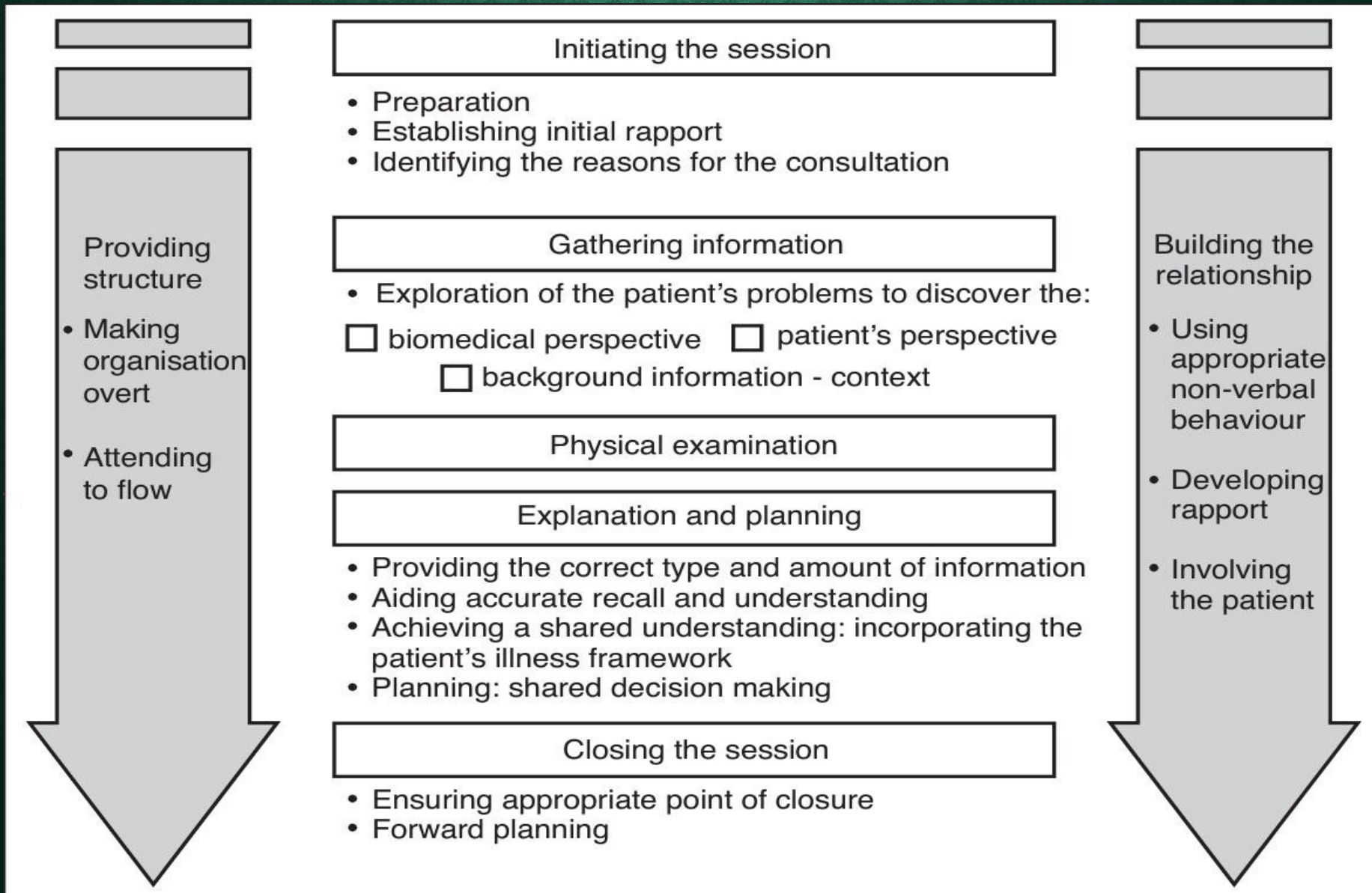
BASIC FRAMEWORK OF CALGARY-CAMBRIDGE



هيكل المقابلة الطبية الشكل (1)



EXPANDED FRAMEWORK



هيكل المقابله الطبيه

Frame work of Medical Interview

بناء العلاقة
Building the relationship

المهارات غير اللفظية
التعبير الوجهي
وضعية الجسم
التعاطف
أظهر ثقه في النفس
الإنصات الفاعل
المظهر الخارجي

Nonverbal communication
- Posture.
- proximity,
- Facial expression & eye contact,
- vocal cues (rate, volume, intonation)
- Empathy
- Demonstrates confidence
- If reads, writes notes or uses computer, does in a manner that does not interfere with dialogue or rapport.
- Attentive Listening

المهارات اللفظية
تقنية الأسئلة
تقبل رؤيه المريض
لتعاطف
وفر الدعم
تجنب مايزعج المريض
الاشتراك بالتفكير مع المريض
تفسير منطقي للاسئله

Verbal communication
- Open/closed questions.
- Empathy
- Provides support (expresses concern and willingness to help)
- Deals sensitively with embarrassing topics)
- Shares thinking with patient.
- Explain rationale.

Initiating the session افتتاح المقابلة

Preparation	التهيؤ
Establishing initial rapport	إرساء الألفة وبناء العلاقة الإنسانية الشخصية مع المريض
Identifying the reason(s) for the consultation	(شلونه العمل ؟ الجو ؟ الحياة) تحديد اسباب المقابله (أحصي جميع المشكلات البدنية والنفسية والإجتماعية)

Gathering information جمع المعلومات

Patient's perspective	**القصة المرضية "محورية المريض"**
Illness	المعاناة
Language embarrassment /	الاعراض المرضية
Culture disparity	والبيانات الثانوية
	الحرج اللغوي
Biomedical perspectives	**الجزء السريري "محورية الطبيب"**
Chief complain(s) /Present illness	الاعراض المرضية وتحليلها
Systemic review	مراجعة اعراض اجهزة الجسم
Past medical / surgical history	التاريخ المرضي السابق
Drug /allergy history	والعائلي والحساسية
Family history	بناء المعلومات وتلخيصها
Social history	
Data review	

Physical examination الفحص البدني

Explain rational for questions or parts of physical examination
Explain process, ask permission

Explanation and planning الخطة العلاجية

Providing correct amount and type of information	اعطاء معلومات مناسبة
Aiding accurate recall and understanding	التعبير البسيط والتأكد من دقة فهم المريض
incorporating patient perspective	ربط الخطة بمنظور المريض
shared decision making	تشجيع المريض على المشاركة في اتخاذ القرار إلى الحد الذي يرغب فيه.
	التأكد من استعداد المريض وقدرته على اتباع الخطة
	ضمان الدعم العائلي والمجتمعي

Closing the session اغلاق المقابلة

Final check / asks if any corrections.	الاستفسار عن مشكلات المريض وهواجسه التي لم يتطرق إليها.
Summarises session	تلخيص النهائي للإجراءات
Contract with patient regarding next steps.	التخطيط المستقبلي

وضع هيكل المقابله
Providing structure to the consultation

التلخيص
الانتقال من مقطع الى اخر (عبارة استهلالية)
تسلسل منطقي
الحرص على الوقت

- Summarization
- Progress from one section to another(signposting....)
- Logical sequence.
- Timing.

INITIATION OF THE SESSION - *REVIEW*



❖Preparation

- Puts aside last task, attends to self-comfort
- Focuses attention and prepares for this consultation

❖Establishing initial rapport

- Greets the patient and obtains patient’s name
- Introduce self, role and nature of interview; obtain consent if necessary
- Demonstrate respect and interest; attends to patient’s physical comfort

❖ Identifying the reason(s) for consultation

- Identifies the patient’s problem by an opening question e.g. ….
- Listens attentively to the patient’s opening statement without interrupting or directing patient’s response
- Confirms lists and screens for further problems

- Negotiates agenda ,taking both patient’s and physician’s needs into account

INITIATION OF THE SESSION PRACTICE - ROLE PLAY - FEEDBACK



GATHERING INFORMATION



Gathering information

Process skills for exploration of the patient's problems

- Patient's narrative
- Question style: open-to-closed cone
- Attentive listening
- Facilitative response
- Picking up cues
- Clarification
- Time-framing
- Internal summary
- Appropriate use of language
- Additional skills for understanding the patient's perspective

Content to be discovered

THE BIOMEDICAL PERSPECTIVE - DISEASE

Sequence of events
Symptom analysis
Relevant systems review

THE PATIENT'S PERSPECTIVE - ILLNESS

Ideas and beliefs
Concerns
Expectations
Effects on life
Feelings

BACKGROUND INFORMATION - CONTEXT

Past medical history
Drug and allergy history
Family history
Personal and social history
Review of systems

Figure 1.3 An example of the interrelationship between content and process.

❖*SKILLS* OF EXPLORATION OF PATIENT'S PROBLEMS

- *Encourage* the patient to tell the story of problems(s)
- Uses *open to closed cone* ,questioning techniques
- *Listens attentively* without interruption
- *Facilitates* patient's responses, verbally and non verbally
- Pics up verbal and non verbal *cues*
- *Clarify* patient's statements that are unclear
- *Summarization* periodically
- Uses concise, *easily understood* questions and comments
- Establishes dates and *sequence* of events

THE BIOMEDICAL PERSPECTIVE

- Sequence of events
- Symptom analysis
- Review of other systems

PATIENT'S PERSPECTIVES

1. PATIENT'S IDEAS AND BELIEVES الافكار والمعتقدات

2. PATIENT'S CONCERNS AND WORRIES الهواجس والمخاوف

3. PATIENT'S EXPECTATIONS الامال

4. EFFECTS ON DAILY LIFE التاثيرات على الحياة اليومية

BACKGROUND INFORMATIONS

- Past medical and surgical history
- Drug and allergy history
- Family history
- Social and personal history
- Female Health History

REFERENCES

1. كتاب فن الحوار الطبي – د.عبدالسلام صالح سلطان – الطبعة الرابعة 2022